

دائرة التخدير والعناية المركزة

ما هو ألم ما بعد الجراحة؟

هو ألم حاد يُرافق العملية الجراحية منذ بدايتها وينتهي عادةً عند التئام الأنسجة التي تضررت خلال العملية

يمكن علاج آلام ما بعد الجراحة بنجاح غالباً، إذ يمكن للأدوية المسكنة الحديثة والتخدير السيطرة على الآلام ومساعدة جسدك على التماثل للشفاء.

من الطبيعي أن تكون لديك مخاوف بشأن الألم الذي قد تعاني منه بعد الجراحة. ومن الطبيعي أيضاً أن تشعر بالقلق تجاه المخاطر المحتملة لتناول مُسكنات قوية للألم. التحكم في الألم وتقليل خطورة الآثار الجانبية أمران مهمان لراحتك وتعافيك وتأهيلك بعد الجراحة.

من الأفضل مناقشة كيفية التخلص من الألم واستخدام مُسكنات الألم قبل الجراحة. وتذكر أن الاستعداد يساعدك على التعامل مع ألمك بشكل أفضل.

هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تؤثر على شدة ألم ما بعد الجراحة، والتي تتمثل بالآتي:

عوامل تتعلق بالمريض: العمر، والشخصية، والتخدير النفسي للعملية.
عوامل متعلقة بالعملية: موضع العملية، وحجم العملية، ومضاعفاتها.
عوامل متعلقة بالتخدير: التخدير للعملية، وطرق التخدير، والمواد المستخدمة.

في كثير من الأحيان لا يكون موقع الجراحة هو المنطقة الوحيدة من عدم الراحة أو سبب الألم. فقد يشعر المريض بما يلي

ألم العضلات: قد يشعر المريض بألم عضلي في الرقبة أو الكتفين أو الظهر أو الصدر بسبب الاستلقاء على طاولة العمليات
ألم الحنجرة: قد يشعر المريض بالحكة أو التمزق في منطقة الحلق
ألم الحركة: الجلوس والجري والسعال كلها أنشطة مهمة بعد الجراحة، ولكنها قد تُسبب ألماً متزايداً في موقع الجرح أو حوله

ما هي مضاعفات ألم ما بعد الجراحة؟

من أبرز مضاعفات الألم بعد الجراحة ما يأتي:

مضاعفات في مجرى التنفس

تثبيت عضلات التنفس يُصعب عملية السعال، والتنفس العميق، وهذا الخل من شأنه أن يُسبب لالتهابات رئوية، أو انخماص الرئة

مضاعفات في القلب

معدل نبضات قلب سريع، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة في استهلاك الأكسجين، وارتفاع مستوى السكر في الدم، وتراكم البول، وتراكم الماء والأملاح، كل هذه يُمكنها أن تؤدي لنوبة قلبية، أو حادثة وعائية دماغية.

المشاكل النفسية

مشاكل نفسية، مثل: اضطرابات في النوم، وقلق، والشعور بقلّة الحيلة، والإنهاك النفسي، والتعب

كيف يتم تقييم ألم ما بعد الجراحة؟

يتم تقييم ألم ما بعد الجراحة لتحديد طريقة علاج الألم، وتقدير فعاليتها، ومن أبرز الطرق المستخدمة ما يأتي

وصف المريض للألم

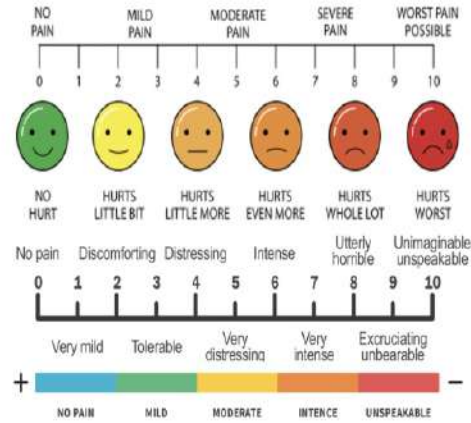
خفيف، أو متوسط، أو شديد، أو ما شابه

المسطرة المرئية لقياس شدة الألم (Visual Analogue Score – VAS)

مسطرة محددة من 0 حتى 10، حيث يُعبر 0 عن عدم وجود ألم، ورقم 10 يُعبر عن وجود أشد ألم يُمكن تصوّره ووجع لا يحتمل.

يُحدد المريض على المسطرة المكان الملائم لشدة الألم الذي يشعر به

يتم تقييم ألم ما بعد الجراحة في وضعيات مختلفة بما في ذلك عندما يكون المريض مرتاحاً، وكذلك عندما يبذل جهداً جسدياً معيناً أثناء التنفس العميق، أو السعال، أو التحرك في السرير، أي بكل فرصة متاحة



من المرجح أن تتحدث مع الجراح قبل العملية الجراحية أو مع طبيب التخدير. وأن تناقش خيارات إدارة الألم وخيارات العلاج واحتياجاتك الخاصة. قد تتحدث عن:

• **توقعات الألم.** اسأل عن الشعور بالألم الذي يرتبط عادة بالجراحة.

اسأل أيضاً عن المدة التي قد يستغرقها التعافي.

• **التجارب السابقة بشأن الألم.** تحدّث مع فريق الرعاية الصحية عن

تجاربك بشأن الألم والطرق المختلفة للسيطرة على الشعور بالألم.

اذكر ما كان مناسباً وما لم يكن مناسباً لك في الماضي.

• **الألم المزمن.** إذا كنت تتناول أدوية لعلاج آلام مزمنة، فدون قائمة

بالأدوية التي تتناولها يومياً ودرجات الألم المعتادة. وناقش الخيارات

مع فريق الرعاية الصحية لعلاج كل من الألم المزمن والألم المتعلق

بالجراحة.

• **قائمة أدويةك.** امنح فريق الرعاية الصحية قائمة بجميع الأدوية

والأدوية الموصوفة التي تتناولها من دون وصفة طبية. كذلك دون أي

مكمّلات غذائية أو أعشاب كنت تتناولها في الماضي. يحتاج أعضاء

فريق الرعاية الصحية إلى معرفة أي شيء قد يتفاعل مع الأدوية

التي تتناولها لتسكين الألم بعد الجراحة. وقد تحتاج إلى تغيير

أدويةك قبل الجراحة وبعدها.

• **مخاوفك بشأن الآثار الجانبية.** اطلب معلومات بشأن الأدوية

الموصوفة لك بعد الجراحة وآثارها الجانبية. واسأل عما يمكن فعله

لتقليل الآثار الجانبية ومتى تحصل على المساعدة عند حدوث آثار

جانبية خطيرة.

أنواع أدوية الألم

للتعامل مع الألم بعد العمليات الجراحية، يُستخدم عادةً أكثر من نوع من الأدوية المسكنة للألم. ويتوقف نوع الدواء المناسب وطريقة تناوله وجرعته على نوع العملية الجراحية والوقت المتوقع للتعافي، وكذلك على الاحتياجات الشخصية.

تشمل مسكنات الألم ما يلي:

• **العقاقير أفيونية المفعول**، وهي مسكنات قوية تقلل من الشعور

بالألم، وقد تُعطى للمريض بعد العمليات الجراحية. قد تشمل العقاقير أفيونية المفعول التي تحقن عبر الوريد أو تُصرف على هيئة أقراص للتناول حسب وضعك الصحي

• **أدوية التخدير الموضعي** التي تُخدر جزءًا من الجسم. وتسبب فقدان الإحساس في جزء من الجسم

• **مضادات الالتهاب غير الستيرويدية** التي تقلل التورم الذي يؤدي إلى تفاقم الألم. تشمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي قد تؤخذ بعد العملية الجراحية.

• **الأسيتامينوفين (الباراسيتامول)**

• **الأدوية الأخرى** التي يمكن أن تعالج الألم بعد إجراء العملية الجراحية الأدوية المضادة للقلق والأدوية المضادة لنوبات الصرع

وقد تكون العقاقير أفيونية المفعول مناسبة للاستخدام بعد العملية الجراحية أو غير مناسبة لحالتك. من المرجح أن يتم وصف مزيجًا من العلاجات. فقد يساعد هذا المزيج على السيطرة على الألم وتقليل الآثار الجانبية. ويمكن أن تساعد العلاجات أيضًا على استئناف النشاط المناسب للتعافي وتقليل المخاطر المتعلقة بالعقاقير أفيونية المفعول.

إدارة مخاطر استخدام الأفيونيات

غالبًا تكون الأفيونيات مثل المورفين أو الفنتانيل ضرورية لإدارة الألم بعد الجراحة نظرًا إلى تأثيرها القوي. ولكنها قد تسبب آثارًا جانبية مثل الغثيان والقيء والإمساك واحتباس البول والنعاس وضعف مهارات التفكير وصعوبة التنفس.

وينطوي الإفراط في تناول الأفيونيات وإساءة استخدامها على مخاطر أيضًا، خاصة عند استخدامها لعلاج الألم المتواصل أو المزمن. وعلى الرغم من أن الأفيونيات تُستخدم بعد الجراحة كإستراتيجية قصيرة المدى لتخفيف الألم أثناء تعافي الجسم، فخطر إساءة الاستخدام يظل مصدر قلق.

وعليك أن تستخدم هذه الأدوية بحذر، إن اضطررت إلى ذلك، نظرًا إلى مخاطرها. ولتقليل المخاطر المذكورة، تناول الأفيونيات بأقل جرعة فعالة ولأقصر فترة ممكنة.

وتحدث إلى طبيبك بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل المخاطر المرتبطة بتناول الأفيونيات، وتشمل:

• تناول الأدوية حسب تعليمات الطبيب، وتناول أقل جرعة فعالة لأقصر فترة ممكنة.

• إبلاغ الطبيب عندما يخرج الألم عن السيطرة.

• الامتناع عن شرب الكحول خلال فترة تناول الأفيونيات.

• اتباع تعليمات فريق الرعاية الصحية بشأن الأدوية الأخرى التي يُمنع تناولها خلال فترة تناول الأفيونيات.

• تخزين الأدوية بأمان.

• التخلص من الأدوية التي لا حاجة إليها، ومن الأفضل أن يكون ذلك من خلال أرجاع الأدوية إلى الصيدلية

• عدم مشاركة الدواء مع الآخرين

تخفيف الألم بعد جراحة كبرى

من الأهداف الرئيسية لعملية إدارة الألم بعد الخضوع لجراحة كبرى أن تستيقظ مرتاحًا نسبيًا وأن تنتقل إلى مرحلة السيطرة على الألم. لكن قد تشعر ببعض الانزعاج، وينبغي أن تتوقع ذلك بعد الجراحة.

مسكنات الألم عبر الوريد: قبل الجراحة، سيُجرى تثبيت أنبوب بلاستيكي رفيع (أنبوب قسطرة) في أحد أوردك أو ذراعك. يسمح أنبوب القسطرة لفريق الرعاية الصحية بإعطائك السوائل أو المهدئات أو الأدوية المخدرة أو المضادات الحيوية أو مسكنات الألم. ويمكن استخدام أنبوب القسطرة لتوصيل مسكنات الألم حتى يمكنك تناول الحبوب عبر الفم.

وتُحقن مسكنات الألم، مثل العقاقير أفيونية المفعول، عادةً في أنبوب القسطرة الوريدي بانتظام. وتوفر أغلب المستشفيات كذلك **نظام تسكين الألم الخاضع لتحكم المريض (PCA)**. وهو نظام يتيح لك أن تعطي نفسك جرعة ثابتة من الدواء بضغط زر. لذلك لن تكون مضطرًا إلى طلب أحد الممرضين للحصول على كل جرعة من مسكن الألم.

يتمتع نظام تسكين الألم الخاضع لتحكم المريض بواقيات مدمجة تمنع الحصول على جرعة مفرطة من مسكن الألم. وإذا ضغطت الزر أكثر من مرة خلال فترة محددة، فإن موزع النظام يتجاهل الطلب الثاني. يمكن استخدام هذه الطريقة لتسكين الألم الخاضع لتحكم المريض للبالغين وأيضًا للأطفال من سن ٦ سنوات وأعلى



• **التخدير الارتشاحي للجرح:** يمكن للجراح أن يحقن دواءً مخدرًا في موضع الجرح أثناء الجراحة. أو يمكنه تثبيت أنبوب قسطرة لتوصيل مسكنات الألم بعد الجراحة. وقد يقلل ذلك من استخدام العقاقير أفيونية المفعول خلال فترة التعافي.

• **التخدير الشوكي:** يمكن إجراء بعض العمليات الجراحية عن طريق التخدير الشوكي، والذي يتضمن حقن أدوية مباشرة في السائل الشوكي.

التخدير الشوكي أسهل وأسرع من التسكين فوق الجافية. لكنه لا يستمر طويلًا نظرًا لعدم وجود أنبوب قسطرة يتيح توصيل مزيد من الدواء إذا لزم الأمر. ويمكن إضافة عقار أفيوني المفعول طويل المدى إلى دواء التخدير الشوكي لتخفيف الألم لمدة تصل إلى 24 ساعة.

• **إحصار العصب:** لإجراء الإحصار العصبي، يُستخدم دواء موضعي مخدر لتوفير راحة استهدافية من الألم في منطقة من جسمك، كذراعك أو ساقك. وهو يمنع رسائل الألم من الانتقال عبر المسار العصبي وصولاً إلى دماغك. يمكن استخدام الإحصارات العصبية في إجراءات المرضى الخارجيين أو العمليات الجراحية للمرضى الداخليين

ولتخفيف الألم لعدة ساعات، تُستخدم الحقن لإجراء الإحصار العصبي. عندما يستلزم الأمر السيطرة على الألم لفترة أطول، يمكن تركيب أنبوب قسطرة لإعطاء الدواء بشكل مستمر أو لتمكين المريض من ضبط إيصال الدواء.

• **التسكين فوق الجافية:** تُحقن الأدوية المسكّنة للألم عبر أنبوب قسطرة يُدخل إلى الحيز فوق الجافية داخل القناة الشوكية ولكن خارج السائل الشوكي. ويُستخدم أنبوب قسطرة فوق الجافية غالباً في حالات المخاض والولادة. ويُستخدم في بعض الأحيان قبل العمليات الجراحية، مثل الولادة القيصرية أو العمليات الجراحية الكبرى في البطن والصدر وبعض جراحات العظام

كيف تعمل القسطرة فوق الجافية؟

يتم وضع القسطرة تحت التخدير الموضعي للبالغين أو بعد التخدير العام للأطفال

يتم توصيل القسطرة بمضخة تحقن من خلالها الادوية المسكنة بجرعات متواصلة أو متقطعة

يتيح لك التسكين فوق الجافية الخاضع لتحكم المريض (PCEA)، مثل نظام تسكين الألم الخاضع لتحكم المريض، أن تعطي نفسك جرعة من الدواء المسكن للألم بضغطة زر. وتوجد فيه كذلك واقيات مدمجة حتى لا تعطي نفسك جرعة مفرطة من الدواء.

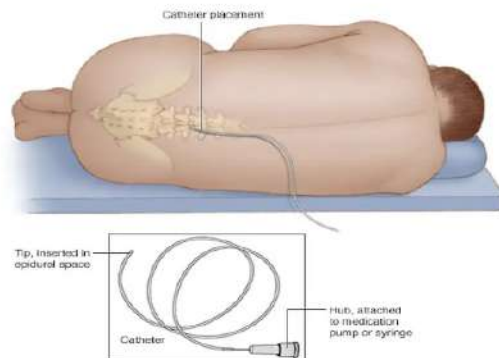
تعمل الادوية على تقليل الإحساس بالألم في الجزء السفلي من الجسم دون التأثير على الوعي

مميزات هذه الطريقة لتسكين الألم

- تسكين فعال للألم
- تقليل الحاجة للمسكنات القوية
- تحسين سرعة التعافي حيث يسمح بالحركة المبكرة والتنفس العميق مما يقلل من مضاعفات ما بعد الجراحة مثل الجلطات والالتهابات الرئوية
- تقليل الضغط على القلب والرئتين

الآثار الجانبية المحتملة

- التسكين فوق الجافية آمن، ولكن مثل أي إجراء أو علاج، فهو ليس خالياً من المضاعفات
- انخفاض ضغط الدم بسبب تأثير المخدر: يتم علاجه بجرعه من السوائل الوريدية والأدوية الرافعة للضغط
- تنميل أو ضعف في الساقين: يتحسن عند تقليل الجرعة أو إزالة القسطرة
- حكة أو غثيان
- احتباس البول: قد يحتاج المريض. لقسطرة بولية لفترة قصيرة
- صداع ناتج عن ثقب الجافية: يمكن علاجه بوسائل طبية



متى يتم إزالة القسطرة؟

عادة تزال القسطرة بعد ٢-٤ أيام من الجراحة عندما يصبح الألم تحت السيطرة ويمكن استخدام المسكنات عن طريق الفم
يتم إيقاف الأدوية تدريجياً لضمان عدم عودة الألم بشكل مفاجئ
إذا كنت على أدوية مسيلة للدم يتم إيقاف تلك الأدوية لعدة ساعات قبل وبعد إزالة القسطرة (الفريق الطبي يتبع بروتوكولات معينة في هذا الشأن)

متى يجب ابلاغ الطبيب؟

- ! فقدان الإحساس أو الحركة في الساقين
- ! ألم شديد في الظهر أو مكان ادخال القسطرة
- ! ارتفاع درجة الحرارة أو علامات التهاب في موضع القسطرة
- ! صداع شديد عن الجلوس أو الوقوف

تسكين الألم بعد جراحة صغرى وأثناء التعافي في المنزل

بعد الجراحة، تُوجه إليك إرشادات للرعاية العامة. قد يشمل ذلك أخذ قسط من الراحة ووضع كمادات باردة وممارسة تمارين إعادة التأهيل والعناية بجرحك
يُحتمل أن تنتقل إلى مسكنات الألم الفموية قبل مغادرة المستشفى، وستواصل تناولها في المنزل للتعامل مع الألم. يُحتمل أن تتناول مجموعة من الأدوية في شكل حبوب قد تتضمن ما يلي:

- العقاقير أفيونية المفعول.
- الأسيتامينوفين (الباراسيتامول)
- مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

تأكد من أنك تعرف ما العنصر النشط في كل مسكن للألم، وما الجرعة المناسبة وعدد مرات تناوله. اسأل أيضاً فريق الرعاية الصحية عن التفاعلات المحتملة مع الأدوية الأخرى. وتشمل هذه الأدوية أدوية نزلات الزكام التي تشتريها من المتجر، والأدوية التي تصرف بوصفة طبية والمكملات الغذائية الأخرى

دورك في السيطرة على الألم

بعد الجراحة، تعاون مع فريق الرعاية الصحية المتابع لحالتك لتعجيل الشفاء وتجنب الألم قدر الإمكان. وتواصل مع أفراد فريق رعايتك الصحية لمساعدتهم على تقييم خطة إدارة الألم وتعديلها.

• كُن صادقاً بخصوص الألم الذي تشعر به بعد الجراحة. أخبر

طبيبك بحجم الألم وموضعه، وبالنشاط أو الوضعيات التي تخففه أو تزيده سوءاً. وقيم شدة الألم على مقياس من 0 إلى 10، حيث يشير 0 إلى عدم وجود ألم، ويشير 10 إلى أسوأ ألم يمكن تخيله. كلما كان التحديد أكثر دقة، كان فريق رعايتك الصحية أكثر قدرة على تقديم المساعدة بشكل أفضل.

• لا تتجاهل الآثار الجانبية. أخبر فريق الرعاية إذا كنت تعاني من

النعاس أو الإمساك أو الغثيان أو أي آثار جانبية أخرى للأدوية. يمكن لتناول مسكنات ألم أخرى أو لتغيير الجرعة في بعض الأحيان أن يقلل من الآثار الجانبية غير المرغوبة، ويمكن علاج هذه الآثار الجانبية والحد منها في كثير من الأحيان.